EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 90817
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2024-08-17 15:43:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: PEDRO ANTONIO ROMERO MOYANO			RUN	: 10.569.889-5
F.Nac	: 28-07-1965	Edad	: 59 AÑOS	Género	: Masculino
Dirección	: La Union, Ninquihue			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 976543709		
Fecha Ingreso	: 2024-07-30	Fecha Egreso	: 2024-08-17 15:43:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. M51.1-TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATIA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Sepsis foco meníngeo- respiratorio
- Bacteremia por SAMR
- Meningitis Aguda Bacteriana por S. Aureus
- Neumonía bibasal/ TQVM
2. Emergencia Hipertensiva
- EPA resuelto.
3. Discopatía degenerativa multisegmentaria lumbar y cervical
a. Raquiestenosis L3-L4 y L4-L5
4. Antecedentes: HTA - DMT2
5. ¿RAM Vancomicina?

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. M51.1-TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATIA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. G04.9-ENCEFALITIS, MIELITIS Y ENCEFALOMIELITIS, NO ESPECIFICADAS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. N17-INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. E10-DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente masculino de 47 años de edad, sin comorbilidades, quien refiere inicio de enfermedad actual el 20/06/2024 aproximadamente, caracterizado por tos productiva con expectoración blanquecina, fiebre no cuantificada, diaforesis nocturna, dificultad respiratoria progresiva evolucionando hasta disnea en reposo, evaluado en aps donde diagnostican amigdalitis e indican amoxicilina por 7 días, sin mejoría. El día 02/07/2024 refiere exacerbación de la disnea por lo que acude a servicio de urgencia ingresando en malas condiciones, desaturando hasta 70%, taquipneico 30 rpm , taquicardico 110 lpm, normotenso, afebril, se solicitan exámenes donde destaca pcr 243,7 leucocitosis 12100 , alcalosis respiratoria, pafi 180, radiológicamente con infiltrado bilateral en vidrio esmerilado, por lo que solicitan evaluación por upc decidiéndose su ingreso

EVOLUCIÓN EN UCI POR SISTEMAS:
Hemodinamia: ingresa a UTI hipertenso recibiendo nitroglicerina en bomba de infusión continua hasta 30 mcg/min, taquicardia sinusal, evoluciona a edema agudo de pulmón, luego de intubarse se omite bic-ntg y 2rio a sedación amerita dva- nad hasta 0.06 mcg/kg/min pero solo durante 24 h, luego se omite, permaneciendo normotenso hasta que se inicia weaning que se torna taquicárdico e

hipertenso, al controlar la agitación-delirium mejora pa-fc y luego tras el inicio de vasodilatadores , primero carvedilol y luego losartan, actualmente hta predominio sistólico leve-moderada ritmo sinusal fc 95-100 lpm , bh negativo, bien perfundido, hb 13.2
Respiratorio: ingresa a uti con fio2 36% por naricera, luego se pasa a mascarilla venturi fio2 35% y 8 horas después se pasa a vmni fio2 53% pero el 31/08/2024 a las 9:20 h por edema agudo de pulmón fr 33-40 rpm fio2 58% manifiesta cansancio-agotamiento decidiendo intubación, se seda con fentanilo/midazolam escalon 12 hasta el 04/08/2024 que se cambia a fentanil/propofol y luego propofol-precedex + bolos de metadona, se retrasa weaning por aparente nuevo hit infeccioso el 06/08/2024 objetivando peaks subfebriles e incremento de parametros inflamatorios, sin embargo ya se encontraba en cpap, no se profundiza sedación y se logra estabilizar, pafi en ese momento 276/308 fio2 28-30% , el 08/08/2024 se realiza pve cpap ps 0-peep 5 resultando vt/fr 43-63-46 decidiendo extubación a las 17:23 h sale a vmni hasta las 10:00h del 09/08/2024 cuando se pasa a naricera fio2 24% y al cabo de 12 h tolerando fio2 21% fr 20-23 rpm pafi 375, saturando 93-95%
Infeccioso: ingresa a hsc con pcr 83 sin describirse fiebre, a las 24 h asciende pcr a 329 y procalcitonina 2,27, se traslada a uci donde igualmente ingresa afebril, pero el día que es recibido en uci presenta peaks subfebriles múltiples hasta 37.5 y se pancultiva y al día siguiente se realiza puncion lumbar con leucocitos 525 50% pmn y 50% mnn , hiperproteinorraquia, sugestivo de infección (meningitis) ajustando antibioticoterapia a dosis meníngea (ceftriaxona-vancomicina) además de dexametasona, dentro de las siguientes 24 h los hemocultivos- y cultivo dieron preliminares cocaceas gram (+) asi como tambien UC . Persiste subfebril y febril hasta el 02/08/2024 . Se mantiene con ambos antibioticos hasta el 06/08/2024 cuando presenta peaks subfebriles escalando de ceftriaxona a meropenem y se toman hc 1-2 que hasta ahora van negativos y uc –cat confirmados sin aislamiento. El 09/08/2024 se omite vancomicina y en su lugar se indica linezolid por aparente ram a la vancomicina. Completó tto con linezolid y meropenem con buena respuesta clínica y de laboratorio
Nefrometabólico: desde su ingreso hiperglicemico 170-199-253, pero no criterios de cetoacidosis ni hhs, luego de inicio de dexametasona asciende hgt entre 280-300 que tuvo que manejarse con bic de insulina, también tuvo ascenso de creatinina de 0.6 al ingreso hasta 1.5 el 02/08/2024 pero con diuresis conservada y sin acidosis metabólica, tampoco alteraciones electrolíticas excepto tendencia a hipernatremia y potasio normal alto pero que actualmente estan corregidos. Actualmente sin conflicto
Neurológico: actualmente consciente, orientado, pc indemnes, fm m5 eeii, m3 eess predominio proximal , rot (++), no rigidez de nuca, glasgow 15 ptos; se realiza alta a domicilio con HODOM para continuar rehabilitación

PLAN DE MANEJO:

- HD/CV: BH neutro, vigilar perfusión.
- Ventilatorio: FiO2 para Sat > o = 92%. KNT respiratoria + motora
- Infeccioso: Completó 8 días con Vancomicina, suspendida el 09/08 por sospecha de RAM, se inicia Linezolid. Sin HC de control a las 48 hrs de inicio de Vancomicina, se decide completar 14 días por Bacteriemia x SAMR asumiendo negatividad (hasta 16/08/24). El 06/08 presenta peack febril asociado a alza de parámetros inflamatorios, se asocia Meropenem, cultivos negativos incluídos HC con px inflamatorios bajos por lo que completó 7 días meropenem. Sin nuevo conflicto actual.
- Renal: Vigilar función renal y ELP. Evitar nefrotóxicos.
- Metabólico: Régimen liviano via oral según tolerancia. HGT c/6 hrs + refuerzo de IC según esquema.

- Proporcionalidad terapéutica: Manejo activo

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Régimen liviano diabético hiposódico
3. Omeprazol 20 mg/día vo
4. Paracetamol 1 gr c/8hrs vo SOSQuetiapina 50 mg/noche vo
5. Bisoporlol 5 mg/día vo
6. Pregabalina 75 mg c/12 hrs vo
7. Tamsulosina 0.4 mg/día vo
8. I. NPH 10 U AM - 6 U PM sc
9. HODOM

EXÁMENES Y RESULTADOS

TAC TÓRAX 06/08/2024: ARBOL TRAQUEO BRONQUIAL PRINCIPAL PERMEABLE. TOT CON EXTREMO CAUDAL A 30 MM CARINA. PULMONES HIPO-INSUFLADOS CON FOCOS DE CONSOLIDACIÓN EN SEGMENTO APICAL Y BASAL POSTERIOR DE LID Y CONSOLIDACIÓN LOBAR ATELECTASICA INFERIOR IZQUIERDA. DERRAME PLEURAL LAMINAR IZQUIERDO. CORAZON DE TAMAÑO NORMAL, SIN SIGNOS DE DERRAME PERICÁRDICO
TAC COLUMNA CERVICAL 30/07/2024: SIN SIGNOS DE LESIONES OSEAS TRAUMÁTICAS. ACENTUADA ESTENOSIS FORAMINAL C5-C6 Y C6-C7 IZQUIERDA Y MODERADA ESTENOSIS FORAMINAL C3-C4 Y C4-C5 IZQUIERDA POR UNCOARTROSIS. MODERADA RAQUIESTENOSIS FOCAL C6-C7
TAC DE COLUMNA LUMBAR: CAMBIOS DEGENERATIVOS. ACENTUADA ESTENOSIS FORAMINAL L3-L4 BILATERAL Y L5 - S1 BILATERAL. MODERADA ESTENOSIS FORAMINAL L4-L5 BILATERAL Y RAQUIESTENOSIS FOCAL L3-L4 Y L4-L5
ANGIOTAC DE TÓRAX 30/07/2024: SIN EVIDENCIA DE TEP. DILATACIÓN DEL TRONCO PULMONAR. CARDIOMEGALIA. SIGNOS SUGERENTES DE EDEMA PULMONAR INTERSTICIO ALVEOLAR
TAC CEREBRAL 30/07/2024: SIN HALLAZGOS DE CARÁCTER AGUDO INTRACRANEANO, NO SIGNOS DE FRACTURA RECIENTE EN CALOTA
TAC DE ABDOMEN Y PELVIS 29/07/2024: QUISTES CORTICALES RENALES BILATERALES, SIN SIGNOS CATEGÓRICOS DE PATOLOGÍA AGUDA
TAC DE TÓRAX 30/07/2024: DEFICIENTE DESCENSO DIAFRAGMATICO CON LOBULACIONES, FOCOS DE CONDENSACIÓN SEGMENTARIOS EN AMBOS LÓBULOS INFERIORES. NEUMONÍA BASAL BILATERAL. DISCRETO AUMENTO VENTRICULAR IZQUIERDA

ECOCARDIOGRAMA 08/08/2024: SIN IMÁGENES SUGERENTES DE VEGETACIONES. VI NO DILATADO CON HIPERTROFIA CONCENTRICA Y FEVI CONSERVADA 66%. SIN TRASTORNOS DE MOTILIDAD SEGMENTARIAS. AURICULA IZQUIERDA NO DILATADA. FUNCIÓN DIASTÓLICA NORMAL. SIN VALVULOPATIAS SIGNIFICATIVAS CAVIDADES DERECHAS NO DILATADAS. FUNCIÓN DEL VD NORMAL

EKG 30/07/2024: RS/82/0.08/0.16/0.10/-30°/0.36 VM TS HBSAHH, CAI
MICROBIOLÓGICO
Hc 1-2 06/08/2024: pdte / Cat 06/08/2024: neg / Uc 06/08/2024: neg / Lcr cultivo 01/08/2024: cocaceas gram (+) racimos / Lcr cultivo 31/07/2024: SAMR
Uc 30/07/2024: neg / Hc 1 30/07/2024: SAMR 14 h-43 min / Hc 2 30/07/2024: samr 14 h-44 min / Uc 28/07/2024: SAMS /
Citoquímico lcr 31/07/2024: Glucosa : 60 mg/dl / Proteinas totales : 3.200 mg/dl / Lactato : 16,2 * mmol/l / Albumina : 1.400 mg/dl / Recuento de leucocitos : 525,0 * mm3 < 5,0 / % polimorfonucleares : 50,0 * o/o < 2,0% mononucleares : 50,0

GONZALO EDUARDO VERA TORRES
MEDICO TRATANTE
16497415-4

JEFE SERVICIO